FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK - SEGUNDA EDICIÓN (BDI-II)

Beck Depression Inventory-II (Beck, Steer & Brown, 1996) · Adaptación Española (Sanz et al., 2003, 2005) · Pearson Clinical

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Inventario de Depresión de Beck - Segunda Edición (Beck Depression Inventory-II, BDI-II)
Sigla / Acrónimo	BDI-II
Autoría original	Aaron T. Beck, Robert A. Steer & Gregory K. Brown (The Psychological Corporation, 1996)
Adaptación en español	Jesús Sanz, L. Perdigón, M. Vázquez et al. (2003, Clin Salud; Sanz et al., 2005, Psicothema)
Constructo evaluado	Presencia y gravedad de sintomatología depresiva según criterios nosológicos DSM-IV y DSM-5
Población diana	Adultos y adolescentes a partir de 13 años en contextos clínicos, forenses y de investigación
Tiempo de aplicación	5 a 10 minutos (autoadministrado o mediante lectura asistida en deterioro motor)
Estructura y formato	21 ítems politómicos con 4 afirmaciones jerarquizadas en severidad creciente (0 a 3 puntos)
Condiciones de uso	Instrumento psicométrico comercial registrado; distribución oficial por Pearson Clinical Assessment. **Protocolo no disponible por derechos de autor (Pearson). Para una alternativa de acceso libre con el mismo propósito de cribado de severidad depresiva, ver PHQ-9 (Eje I) o CES-D (Eje I).**

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El BDI-II es el patrón oro psicométrico autoinformado a nivel internacional para cuantificar la intensidad de los episodios depresivos. Se fundamenta sólidamente en el **Modelo Cognitivo de la Depresión** formulado por Aaron T. Beck, el cual postula que la sintomatología afectiva está mediada por la activación de esquemas disfuncionales latentes y distorsiones cognitivas automáticas organizadas en torno a la **Tríada Cognitiva Negativa**: una visión distorsionada y pesimista sobre sí mismo ("soy un fracasado"), sobre el mundo/entorno ("todo es hostil e injusto") y sobre el futuro ("nada va a mejorar jamás").

A diferencia de la versión original del BDI de 1961 (que evaluaba la última semana), el BDI-II amplió su marco temporal a las **dos últimas semanas** para alinearse con los criterios temporales diagnósticos del Trastorno Depresivo Mayor del DSM-IV/5. Asimismo, incorporó reactivos representativos de la depresión atípica (hiperfagia, hipersomnia) e incrementó la sensibilidad para detectar agitación psicomotora, desvalorización personal y anhedonia.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Factorial	Ítems Origen	Rango	Contenido y Operacionalización Clínica
Dimensión Cognitivo-Afectiva	Ítems 1 a 14	0 - 42	Tristeza, pesimismo, fracaso pasado, pérdida de placer, culpa, castigo, disconformidad, autocrítica, pensamientos suicidas, llanto, agitación, pérdida de interés, indecisión e inutilidad
Dimensión Somático-Vegetativa	Ítems 15 a 21	0 - 21	Pérdida de energía, cambios en el patrón de sueño (insomnio/hipersomnia), irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio/fatiga y pérdida de interés en el sexo

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad; alfa de Cronbach $\alpha = 0.89 - 0.92$ en muestras clínicas psiquiátricas españolas y $\alpha = 0.87$ en población general comunitaria (Sanz et al., 2003, 2005).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 1 mes: $r = 0.72 - 0.84$ en pacientes sin cambios en el tratamiento, demostrando sensibilidad al estado activo.
Validez convergente	Correlación muy alta con la Escala de Depresión de Hamilton (HDRS, $r = 0.73 - 0.80$), la Escala de Depresión del CES-D ($r = 0.79$) y el BDI-IA original ($r = 0.93$).
Estructura factorial	Los análisis factoriales confirmatorios ratifican una estructura jerárquica con un factor general de Depresión de segundo orden y dos factores oblicuos: Cognitivo-Afectivo y Somático.
Sensibilidad al cambio	Capacidad psicométrica óptima para monitorizar la respuesta terapéutica a psicofármacos y psicoterapia cognitivo-conductual (MCID $= 5$ puntos de reducción).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal evaluado	El paciente debe seleccionar la afirmación que mejor describa cómo se ha sentido durante las **últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy**.
Regla de respuestas múltiples	Si el examinado marca más de una opción dentro de un mismo ítem, se codifica exclusivamente la opción con la **puntuación numérica más alta**.
Puntuación directa global	Suma aritmética simple de los 21 ítems. Rango teórico posible: **0 a 63 puntos**. No existen ítems con puntuación invertida.
Gestión de omisiones	Se tolera como máximo la omisión de 2 ítems ($< 10\%$), calculando la puntuación media proporcional; si faltan ≥ 3 ítems, el protocolo se considera no computable.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación BDI-II	Percentil Aprox.	Nivel de Gravedad	Interpretación Clínica y Diagnóstica
0 - 13 puntos	< Pc 60	Mínima / No Depresión	Variaciones afectivas normales de la vida cotidiana; sin significación clínica.
14 - 19 puntos	Pc 65 - Pc 79	Depresión Leve	Síntomas afectivos moderados; interferencia funcional incipiente o distimia.
20 - 28 puntos	Pc 80 - Pc 89	Depresión Moderada	Cuadro clínico manifiesto; criterio compatible con episodio depresivo mayor.
29 - 63 puntos	>= Pc 90	Depresión Grave / Severa	Afectación psicofisiológica severa; alto riesgo de melancolía o suicidio.

PUNTOS DE CORTE Y ALERTA DE SEGURIDAD CRÍTICA:

- **Punto de Corte Clínico Óptimo (BDI-II ≥ 14):** Sensibilidad del 84% y especificidad del 86% para cribado de trastorno depresivo mayor en España.
- **ALERTA ROJA INMEDIATA (Ítem 9 ≥ 1):** Cualquier puntuación superior a 0 en el Ítem 9 ("Pensamientos o deseos de suicidio") exige la activación inmediata de un protocolo de evaluación del riesgo autolítico mediante entrevista clínica y escalas especializadas (BSS / C-SSRS).

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN ESCALONADA

Paso 1: Cálculo del BDI-II Total: Obtener la suma directa de los 21 ítems.
Paso 2: Inspección Previa Obligatoria: Verificar inmediatamente el Ítem 9 (Ideación Suicida) y el Ítem 2 (Pesimismo/Desesperanza). Si Ítem $9 \geq 1$, pasar a valoración urgente de seguridad.
Paso 3: Si BDI-II $14 - 19$ (Leve): Iniciar intervenciones psicológicas de baja intensidad (activación conductual, resolución de problemas) o apoyo en atención primaria; monitorizar a las 2 semanas.
Paso 4: Si BDI-II $20 - 28$ (Moderada): Psicoterapia formal estructurada (TCC o Terapia Interpersonal) de primera elección; valorar coadyuvancia con antidepresivos (ISRS / IRSN) según preferencia del paciente y antecedentes.
Paso 5: Si BDI-II $29 - 63$ (Grave): Tratamiento combinado obligatorio (farmacoterapia antidepresiva a dosis plenas más psicoterapia); derivación preferente a Centro de Salud Mental / Psiquiatría.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN SALUD MENTAL

Identificación: Paciente varón de 42 años, docente de secundaria, remitido por atención primaria por anhedonia total, insomnio de mantenimiento y pérdida de 6 kg de peso tras un divorcio conflictivo.
Evaluación BDI-II Inicial: Puntuación Total = **34 / 63** (Depresión Grave).
- Desglose clínico: Dimensión Cognitivo-Afectiva = 21/42; Dimensión Somática = 13/21. Ítem 2 (Pesimismo) = 3; Ítem 4 (Pérdida de placer) = 3; Ítem 9 (Ideación suicida) = 1 ("Tengo pensamientos de suicidio, pero no los llevaría a cabo"); Ítem 16 (Patrón de sueño) = 3 (despertar 2 horas antes).

Diagnóstico: Trastorno Depresivo Mayor, episodio único, grave, sin características psicóticas (DSM-5).
Intervención: Pauta combinada de sertralina 100 mg/día asociada a Terapia Cognitiva de Beck (reestructuración de pensamientos automáticos de fracaso y programa de reactivación conductual progresiva). Contrato de seguridad ambulatorio.
Reevaluación a las 8 semanas: El BDI-II descendió a **11 / 63** (Rango mínimo/remisión clínica, reducción de 23 puntos), Ítem 9 = 0, restableciéndose el apetito y la funcionalidad laboral plena.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Autolítico:
- **Ideación Suicida Activa:** Si el Ítem 9 es ≥ 2 ("Querría suicidarme" o "Me suicidaría si tuviera la oportunidad"), no dejar solo al paciente y derivar a Urgencias de Psiquiatría.
- **Melancolía y Síntomas Psicóticos:** Delirios de ruina o culpa extrema exigen despistaje psiquiátrico urgente.

Diagnóstico Diferencial:
- **Depresión Bipolar:** Descartar antecedentes de hipomanía/manía previa (administrar MDQ) antes de pautar antidepresivos solos.
- **Enfermedades Médicas:** En patologías crónicas (cáncer, dolor), los ítems somáticos pueden inflar el total falsamente; focalizarse en el factor cognitivo-afectivo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). **Manual for the Beck Depression Inventory-II**. Psychological Corporation.
- Sanz, J., Perdigón, A. L., & Vázquez, C. (2003). Adaptación española del Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II): 2. Propiedades psicométricas en población general. **Clínica y Salud**, 14(3), 249-280.
- Sanz, J., García-Vera, M. P., Espinosa, R., Fortún, M., & Vázquez, C. (2005). Adaptación española del Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II): 3. Propiedades psicométricas en pacientes con trastornos psicológicos. **Psicothema**, 17(4), 637-643.
- Wang, Y. P., & Gorenstein, C. (2013). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory-II: a comprehensive review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, 35(4), 416-431.